

ISSN 1413-0130



Revista Brasileira de
CIÊNCIA VETERINÁRIA
Brazilian Journal of Veterinary Science

Volume 9 - Número 1 - Janeiro / Abril 2002

Avaliação clínica e radiográfica da técnica de estabilização extra-articular com enxerto autógeno de fáscia lata empregada em cães com ruptura de ligamento cruzado cranial

Clinic and radiographic evaluation of the extra-capsular stabilization with fascia lata autogenous graft applied in dogs with cranial cruciate ligament rupture

Patrícia Popak Maria¹, Mariana Carolina Leite Ribeiro², Luis Paulo Dias Cesar³, Fabrício Bernardo de Jesus Brasil⁴

Resumo

A ruptura do ligamento cruzado cranial (RLCCr) é uma das lesões mais comuns nos membros pélvicos dos cães, sendo a principal causa de doença articular degenerativa do joelho. Existem vários procedimentos cirúrgicos, entretanto nenhum deles se revelou superior aos demais. O presente trabalho utilizou 12 cães com peso variando entre 20 e 45 kg, portadores de RLCCr os quais foram submetidos à técnica de estabilização extra-articular com enxerto autógeno de fáscia lata. Foram analisados no período pós-operatório a claudicação, grau de atrofia muscular, movimento de gaveta, crepitação, espessamento da cápsula articular e grau de degeneração articular. A técnica empregada ofereceu estabilidade parcial ao joelho e todos os cães apresentaram progressão da osteoartrite, porém com ausência de claudicação.

Palavras-chave: ligamento cruzado, cão, enxerto

Abstract

The cranial cruciate ligament rupture (CCLR) is one the most common injuries in the hind limbs of the dogs and the main cause of degenerative articular joint disease. There are a lot of surgical techniques, however none of them was revealed superior to the others. In the present study 12 dogs with CCLR and body weight varying between 20 and 45 kg were used. They were submitted to extra-capsular stabilization with fascia lata autogenous graft. Lameness at walk, muscle atrophy, cranial instability (cranial drawer sign or tibial compression test), crepitation on manipulation, joint thickening and degree of articular degeneration were analyzed in the post-surgery period. The technique offered partial stability to the stifle and all the dogs presented progression of the osteoarthritis, however without lameness.

Keywords: cruciate ligament, dog, graft

Introdução

A ruptura do ligamento cruzado cranial (RLCCr) é uma das lesões mais comuns nos membros pélvicos dos cães, sendo a principal causa de doença articular degenerativa do joelho nesta espécie, e tem sido identificada em cães de todas as raças, idades e tamanhos (Korvick, et al., 1994; Vasseur et al., 1996). O ligamento cruzado cranial fornece estabilidade cranio-caudal ao joelho prevenindo hiperextensão e limitando a rotação interna da tíbia em relação ao fêmur durante a flexão (Moore & Read, 1996 a).

São propostos para correção da RLCCr métodos conservativos e várias técnicas cirúrgicas, porém, o sucesso

do tratamento depende do restabelecimento da estabilidade articular. As técnicas extracapsulares conferem estabilidade pois promovem o espessamento periarticular em resposta ao procedimento cirúrgico e às suturas implantadas, e desta forma, garantem a estabilidade imediata da articulação. Além disso, são menos complicadas tecnicamente e trazem resultados semelhantes às técnicas intra-articulares mais complexas (Korvick, et al., 1994; Moore & Read, 1996 b, Vasseur et al., 1996).

Assim o presente estudo tem por objetivo avaliar os efeitos da técnica extra-articular com enxerto autógeno de fáscia lata aplicada ao redor da fíbula lateral em cães com ruptura do ligamento cruzado cranial.

¹ CREUPI - Av Hélio Vergueiro Leite, s/n, CP 05, CEP 13990-000 - Espírito Santo do Pinhal SP - patriciapopak@zipmail.com.br

² CREUPI - Av Hélio Vergueiro Leite, s/n, CP 05, CEP 13990-000 - Espírito Santo do Pinhal SP - mcleiteribeiro@hotmail.com

³ CREUPI - Av Hélio Vergueiro Leite, s/n, CP 05, CEP 13990-000 - Espírito Santo do Pinhal SP - lpdcesar@bol.com.br

⁴ CREUPI - Av Hélio Vergueiro Leite, s/n, CP 05, CEP 13990-000 - Espírito Santo do Pinhal SP - bjasil@ig.com.br

Material e Métodos

Foram utilizados 12 cães com peso variando entre 20 e 45 kg, portadores de ruptura do ligamento cruzado cranial. Na anamnese foram colhidas informações referentes à idade, peso, raça, tempo de evolução da claudicação e traumatismos. Foram analisados claudicação, grau de atrofia muscular, movimento de gaveta, crepitação e espessamento da cápsula articular. O exame radiográfico foi realizado onde buscou-se evidenciar deslocamento cranial da tibia, presença de osteófitos e de derrame articular.

Após tricotomia e anti-sepsia, foi realizada incisão de pele na região compreendida entre o trocânter maior e o terço proximal da tibia na face lateral. A fásia lata sofreu incisão transversal na porção proximal ao trocânter maior e divulsão até a crista tibial, formando uma faixa de 07 a 10 cm de comprimento e 1 cm de largura. Realizou-se artrotomia lateral para remoção do ligamento rompido e inspeção dos meniscos. A meniscectomia foi realizada quando necessária. A tira de fásia lata foi passada ao redor do tendão do músculo gastrocnêmio e suturada à sua inserção. O joelho foi mantido em angulação de 140° e em discreta rotação lateral. Os pacientes foram medicados com Amoxicilina Trihidratada (Bactrosina O, Bayer) e Flunixin Meglumine (Banamine O, Schering-Plough) no pós-operatório.

Resultados

A idade média dos animais operados era de 5,5 anos e o peso médio 33,75 kg. Quanto às raças, foram atendidos 4 rotweillers, 3 filas brasileiros, 1 weimaraner, 1 pastor alemão e 3 sem raças definidas. Em média os animais foram encaminhados com 62 dias de lesão. Dos animais operados 7 (58,33%) não apresentavam histórico de traumatismo anterior e 4 (33,34%) apresentaram ruptura do menisco medial.

Quanto à claudicação no período pós-operatório, 5 (41,66%) cães não claudicavam aos 30 dias e 7 (57,34%) deixaram de manifestar este quadro aos 60 dias. O apoio do membro foi iniciado por 5 animais aos 15 dias, 4 aos 21 dias e 3 aos 30 dias. Com relação à atrofia muscular, todos animais que apresentavam atrofia no período pré-operatório voltaram a ganhar massa muscular após a estabilização cirúrgica. Com exceção de um animal que apresentou instabilidade crânio-caudal moderada aos 30 dias, todos os outros cães apresentaram-se com instabilidade discreta (2 mm) neste mesmo período. Todos os cães desenvolveram no período pós-operatório alterações articulares degenerativas de grau discreto à grave, a qual incluiu aumento da radiopacidade articular, presença de osteófitos e espessamento de tecidos moles.

A avaliação radiográfica também indicou em 5 (41,66%) cães a continuação do desvio cranial da tibia em relação ao fêmur aos 60 dias, a despeito dos cães não apresentarem claudicação. Aos 90 dias os proprietários foram questionados à respeito da claudicação e nenhum dos animais apresentava este sintoma.

Discussão

A escolha da técnica de sutura lateral para estabilização do joelho, baseou-se na facilidade de execução, que implica em menor tempo cirúrgico, com resultados similares ou superiores às técnicas intra-articulares e à transposição da cabeça da fíbula em cães com mais de 15 kg como demonstrado por Beckman et al. (1992) e Chauvet et al. (1996).

A partir dos resultados clínicos satisfatórios obtidos por Aiken et al. (1992) em cães com peso inferior à 15 kg, pretendeu-se verificar o desempenho da fásia lata na sutura fabelar lateral em cães com peso superior à 15 kg. A ausência de traumatismos prévios em cães afetados pela RLCCr também foi evidenciada por outros autores em uma população de 54 animais, dos quais apenas um sofrera este tipo de acidente (Galloway & Lester, 1995).

Os animais do presente estudo apresentaram tempo de claudicação entre 25 e 360 dias, esses resultados são semelhantes aos descritos na literatura, que registra maior frequência de cães com claudicação crônica (Dickel et al., 1999). Aos 30 dias, 41,66% dos animais exibiam retorno à função do membro operado, resultados superiores àqueles encontrados por Dickel et al. (1999) que registram 90% da amostra estudada sem apoiar normalmente o membro operado aos 21 dias de pós-operatório.

A presença de atrofia muscular da coxa foi compatível com os achados de Moore & Read (1995). De conformidade com os achados de Vasseur & Berry (1992) e Chauvet et al. (1996), neste estudo a maioria dos cães operados apresentou algum grau de instabilidade cranial, porém não influenciando no aparecimento ou manutenção da claudicação.

Todos os cães desenvolveram a progressão da doença articular degenerativa em grau discreto à grave, de concordância com os autores (Monnet et al., 1995; Chauvet et al., 1996; Vasseur et al., 1996) que afirmam que não existe procedimento cirúrgico capaz de impedir a progressão da osteoartrite.

Segundo Monnet et al. (1995) embora a maioria das técnicas forneçam estabilização adequada ao joelho, elas não levam à movimentação normal desta articulação, alterando seu biomecanismo o que pode auxiliar a moléstia articular degenerativa. Desta maneira, segundo Chauvet et al. (1996), deve-se buscar a associação entre satisfação do proprietário e facilidade de execução da técnica empregada, ambos alcançados neste trabalho.

Conclusões

A fásia lata utilizada na técnica extra-articular foi adequada para a correção da ruptura do ligamento cruzado cranial em cães com peso inferior a 45 kg. A técnica ofereceu estabilidade parcial ao joelho e todos os cães apresentaram progressão da osteoartrite, porém com ausência de claudicação.

Referências

- AIKEN, S.W., BAUER, M.S., TOOMBS, J.P. Extra-articular fascial strip repair of the cranial cruciate deficient stifle: technique and results in seven dogs. *V.C.O.T.*, v.5, p. 145-50, 1992.
- BECKMAN, S.L. et al. Technique for stabilizing the stifle with nylon bands in cases of rupture anterior cruciate ligaments in dogs. *J. Am. Anim. Hosp. Assoc.*, v.28, p. 539-43, 1992.
- CHAUVET, A.E. et al. Evaluation of fibular head transposition, lateral fabellar suture, and conservative treatment of cranial cruciate ligament rupture in larges dogs: a retrospective study. *J. Am. Anim. Hosp. Assoc.*, v.32, p. 247-55, 1996.
- DICKELE, G. et al. Étude histologique de la synoviale du grasset et examen des facteurs épidémiologiques de rupture spontanée du ligament croisé crânial. *Prac. Med. Chirurg. L'Animmal Comp.*, v. 34, n.6, p.701-7, 1999.
- DUPUIS, J.; HARARI, J. Cruciate ligament and meniscal injuries in dogs. *Comp. Cont. Education Pract. Vet.*, v.15, n.2, p.215-21, 224-32, 1993.
- GALLOWAY, R.H.; LESTER, S.J. Histopathological evaluation of canine stifle joint synovial membrane collected at the time of repair of cranial cruciate ligament rupture. *J. Am. Anim. Hosp. Assoc.*, v.31 p. 289-94, 1995.
- KORVICK, D.L. et al. Surgeon's preferences in treatment cranial cruciate ligament ruptures in dogs. *J. Am. Anim. Hosp. Assoc.*, v.205, n.9, p.1318-24, 1994.
- MONNET, E. et al. Popliteal tendon transposition for stabilization of the cranial cruciate ligament deficient stifle joint in dogs: an experimental study. *Vet. Surg.*, v. 24, n.6, p. 465-75, 1995.
- MOORE, K.W., READ, R.A. Cranial cruciate ligament rupture in the dog – a retrospective study comparing surgical techniques. *Aust. Vet. J.*, v. 72, n.8, p.281-5, 1995.
- MOORE, K.W., READ, R.A. Rupture of cranial cruciate ligament in dogs – Part I. *Comp. Cont. Educ. Pract. Vet.*, v.18, n.3, p.223-34, 1996a.
- MOORE, K.W., READ, R.A. Rupture of cranial cruciate ligament in dogs – Part I. *Comp. Cont. Educ. Pract. Vet.*, v.18, n.4, p.381-91, 1996b.
- VASSEUR, P.B., BERRY, C.R. Progression of stifle osteoarthritis following reconstruction of the cranial cruciate ligament in 21 dogs. *J. Am. Anim. Hosp. Assoc.*, v.28, p. 129-36, 1992.
- VASSEUR, P.B. et al., Evaluation of the leeds-kelo synthetic replacement for the cranial cruciate ligament in dogs: an experimental study. *V.C.O.T.*, v.203, n.7, p. 1016-9, 1996.